BILAN DE MOBILITÉ & Condition physique — VERSION 1.1

Les tests doivent être catégorisés en 5 parties

I. **Mobi "pure" statique**
II. **Mobi active**
III. **Proprioception**
IV. **Gainage dynamique et statique**
V. **Tests de prépa physique simple**

Les tests maison ne servent pas à performer. Ils servent à valider l'absence de freins fonctionnels majeurs **avant de viser des standards de santé.**	➢ les tests 1 → 5 = **porte d'entrée** ➢ STANDARD 2026 = **cible progressive**

1°) 10 + 3 Tests fondamentaux Mobilité statique

Grille de scoring (0 / 1 / 2 / 3)

0 = Impossible / douleur / arrêt
1 = Mouvement partiel, compensation évidente
2 = Mouvement complet avec légère compensation
3 = Mouvement complet, fluide, sans compensation

Score maximal : 10 tests × 3 points = 30

Tests, critères et score

Test 1 – Assis sur les talons (flexion genou/cheville)

Critère : s'assoir sur ses talons 10 sec, buste droit, sans douleur.

- **3** = Position tenue 10 sec, fluide, aucune gêne
- **2** = Position atteinte mais inconfort / bras nécessaires
- **1** = Ne tient pas 10 sec ou douleur modérée
- **0** = Impossible / douleur aiguë

Score : ……/3

Test 2 – Squat complet pieds à plat (10 sec)

Critère : pieds stables, talons au sol, bassin sous la parallèle, buste non effondré.

- **3** = 10 sec stable, dos neutre, talons ancrés
- **2** = Profondeur OK mais stabilité moyenne / talons décollent légèrement
- **1** = Squat partiel ou buste effondré
- **0** = Impossible / douleur

Score : ……/3

Test 3 – Flexion avant unilatérale (ischios)

Critère : mains au sol de chaque côté du pied avant, jambes tendues, tenue 10 sec.

- **3** = Mains au sol G + D sans compensation
- **2** = Une main touche ou légère flexion de genou
- **1** = Incapacité un côté
- **0** = Aucun côté

Score : ……/3

Test 4 – Wall Shoulder Flexion (bras au mur)

Critère : bras tendus, mains au mur jusqu'à > oreilles, sans hyperlordose.

- **3** = Bras montent au-dessus des oreilles sans décoller le dos
- **2** = Bras montent mais légère compensation lombaire
- **1** = Amplitude réduite / contact main-mur perdu
- **0** = Impossible

Score : ……/3

Test 5 – Rotation interne épaule au sol

Critère : amener la main au sol sans décoller l'omoplate.

- **3** = Main au sol G + D
- **2** = Main proche du sol
- **1** = Limité unilatéral
- **0** = Bilatéral limité / douleur

Score : ……/3

Test 6 – Rotation thoracique (main derrière la tête)

Critère : coude qui monte haut, thorax visible en rotation, pas de compensation lombaire.

- **3** = Rotation ample G + D, ligne du coude bien ouverte
- **2** = Rotation correcte mais limitée d'un côté
- **1** = Rotation faible ou compensations
- **0** = Impossible

Score : ……/3

Test 7 – Mobilité cheville contre mur

Critère : genou à 8–10 cm du mur sans décoller talon.

- **3** = 8–10 cm G + D
- **2** = 5–7 cm
- **1** = <5 cm ou asymétrie > 2 cm
- **0** = Impossible / douleur

Score : ……/3

Test 8 – Test du psoas contre le mur

Critère : bassin neutre, jambe arrière qui descend sous la parallèle.

- **3** = Jambe basse G + D, bassin stable
- **2** = Amplitude correcte mais légère bascule antérieure
- **1** = Limitation un côté
- **0** = Bilatéral limité

Score : ……/3

Test 9 – Rotation interne de hanche (fessier)

Critère : être capable de décoller le pied arrière pendant 10s, le buste tourné vers le genou en rotation interne (posture jambes en croix au sol)

- **3** = Le pied décolle facilement
- **2** = Le pied décolle mais retombe avant 10s
- **1** = Le pied ne décolle pas
- **0** = La posture seule est douloureuse

Score : ……/3

Test 10 – Bridge inversé (extension d'épaule + chaîne antérieure)

Critère : capacité à monter le bassin et aligner épaules–hanches–genoux, bras tendus, sans pincement antérieur.

- **3** = Alignement complet tenu 10 sec, bras parfaitement tendus, ouverture thoracique fluide, aucune compensation
- **2** = Position correcte mais légère flexion des bras ou bassin légèrement bas
- **1** = Incapacité à aligner le bassin ou forte raideur antérieure (petit pectoral / deltoïde antérieur)
- **0** = Impossible de monter en bridge / douleur antérieure nette

Score : ……/3

Total mobilité passive (sur 30)

TOTAL : …… / 30

Il manque 3 tests :

- **Extension hanche** plus spécifique (Thomas test simplifié / fente genou au sol chronométrée)
- **Rotation externe hanche** (90/90 passif ou "figure-4" supine)
- **Extension thoracique** (sur mur ou sur rouleau) — souvent limitante avec l'âge + posture écran

4. Interprétation des résultats

24–30 — OK (Mobilité fonctionnelle optimale)

- Amplitudes complètes et symétriques.
- Adapté au sport, au renforcement, à la prévention.
- Faible risque articulaire.

16–23 — Limité (mobilité insuffisante dans au moins 2 zones clés)

- Chevilles limitées
- Épaules raides
- Rotation thoracique réduite
- Squat instable
  → Risque de compensation, fatigue mécanique, inefficacité technique.

0–15 — Très limité (restrictions majeures)

- Plusieurs articulations clés verrouillées
- Mouvement global altéré
- Risque élevé de blessure
- Travail de mobilité prioritaire avant intensification sportive

2°) 7 Tests fondamentaux Mobilité active

Grille de scoring (0 / 1 / 2 / 3)

0 = Impossible / douleur / arrêt
1 = Mouvement partiel, compensation évidente
2 = Mouvement complet avec légère compensation
3 = Mouvement complet, fluide, sans compensation

Score maximal :

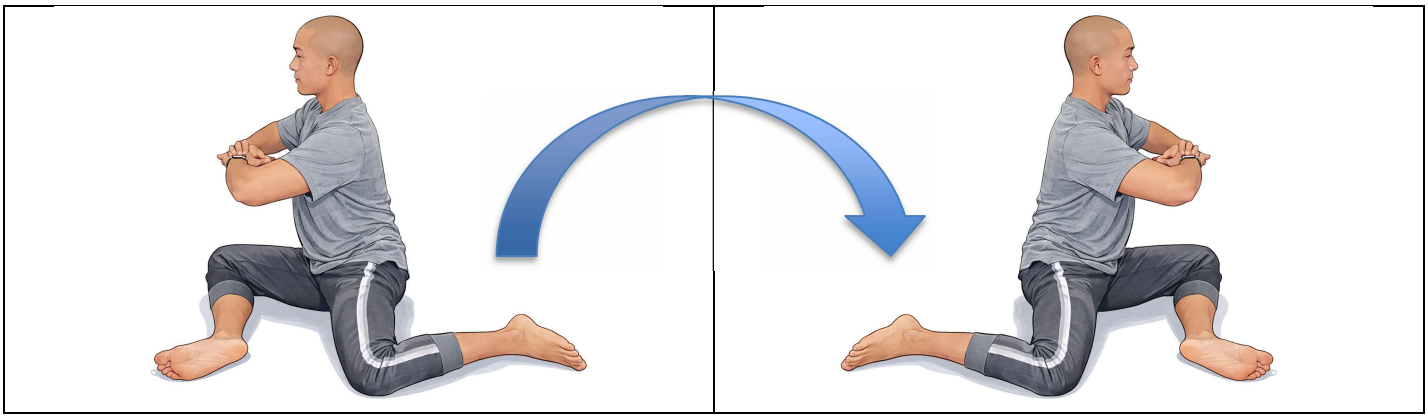
Tests, critères et score

Test 1 – Hurdler debout rotation interne de fessier

Critère : se tenir droit, le genou le plus haut possible, le pied arrière au niveau du genoux

- **3** = Position tenue 60s
- **2** = Position tenue 30s
- **1** = Position tenue 15s
- **0** = Position tenue moins de 15s ou non tenue

Test 2 – Alterner rotation interne et externe



Critère : Si possible, le faire sans s'aider des mains, sinon le faire avec les mains. Les genoux doivent toucher le sol de chaque côté pour valider une répétition. Faire 10 allers-retours.

- **3** = Réaliser l'ensemble sans pauser les mains au sol
- **2** = Réaliser l'ensemble avec les mains au sol
- **1** = Ne pas réaliser l'ensemble des 10 répétitions sans faire d'arrêt
- **0** = Posture de départ douloureux

Test 3 – Rotation externe + quadriceps : le squat sumo

Critère : Ecartement des pieds deux fois la largeur d'épaule. Mains derrière la tête, croisées. Pied à 10h10. Descendre en demi squat, juste avant la parallèle. Garder les genoux alignés avec les pieds pour activer au max les moyens fessiers. Buste relevé, dos droit.

- **3** = Position tenue 90s
- **2** = Position tenue 60s
- **1** = Position tenue 30s
- **0** = Position tenue moins de 30s ou non tenue

Test 4 – Rotation externe + interne + équilibre : l'aviateur

Critère :

- **3** = Être capable de faire 5 reps de chaque côté sans s'appuyer pour s'équilibrer
- **2** = Être capable de faire 5 reps de chaque côté avec appui contre le mur
- **1** = Devoir reposer son pied lors de l'exercice
- **0** = Impossible de faire une seule rep

Il manque aussi 3 tests :

□ **Contrôle scapulo-huméral actif** (élévation bras, wall slide actif, “lift-off” léger)

Critère : bras montent > oreilles, dos et bassin plaqués.

3 = Mouvement complet sans compensation
2 = Mouvement complet avec légère hyperlordose
1 = Amplitude réduite ou perte du contact mur
0 = Douleur ou impossibilité

□ **Contrôle lombo-pelvien** (hinge, step-down contrôlé, SLR actif)

Critère : genou aligné, bassin stable, descente lente.

3 = 15 reps propres G + D
2 = Légère instabilité ou asymétrie
1 = Valgus marqué ou contrôle insuffisant
0 = Douleur ou impossibilité de faire les 15rep

□ **Dorsiflexion active** et “pied/cheville” en charge

Critère : genou avance sans décoller le talon.

3 = Mouvement fluide, stable, symétrique
2 = Amplitude correcte mais instabilité
1 = Amplitude faible ou asymétrie marquée
0 = Douleur ou incapacité

3°) 6 ? Tests Proprioception

Grille de scoring (0 / 1 / 2 / 3)

Statique

- Unipodal yeux ouverts (temps max)

3 = ≥45 s stable
2 = 20–44 s
1 = 5–19 s
0 = <5 s ou impossible

- Unipodal yeux fermés (temps max) (déjà dans STANDARD 2026)

3 = ≥30 s
2 = 20–29 s
1 = 10–19 s
0 = <9 s

- Tandem stance (pied devant l'autre) yeux ouverts puis fermés

3 = 30 s stable sans mouvement parasite
2 = 15–29 s
1 = <15 s
0 = Impossible

Dynamique

- Tandem walk (marche sur une ligne) : nb de pas propres

3 = ≥10 pas propres consécutifs
2 = 6–9 pas
1 = 3–5 pas
0 = <3 pas

- Star excursion / Y-balance simplifié (3 directions) : symétrie D/G

?

- Step-over + contrôle (enjamber un petit obstacle, 10 reps) : stabilité

3 = 10 reps fluides, stables
2 = 10 reps avec légère instabilité

1 = <10 reps ou déséquilibres fréquents
0 = Impossible / peur marquée

Réactif / prévention chute

- “Reactive step test” simple : à voir ?
- “Turn 180°” rapide contrôlé : stabilité + vertiges/ataxie ?

3 = Demi-tour fluide, stable
2 = Léger déséquilibre récupéré
1 = Plusieurs pas nécessaires
0 = Instabilité majeure / vertig

4°) ?? Tests Gainage dynamique et statique

Grille de scoring (0 / 1 / 2 / 3)

Anti-extension / lombaires

- Bird-dog (tenue 10s / répétitions)

3 = Tenue 10 s × 5 reps / côté, bassin stable (donc à chaque rep tenir 10s)
2 = Tenue correcte avec légers tremblements
1 = Perte fréquente de stabilité
0 = Impossible / douleur lombaire

- Dead bug (lent, contrôle respiratoire)

3 = Lombaires stables, respiration contrôlée
2 = Léger décollement lombaire
1 = Mouvement partiel
0 = Impossible

- Planche

3 = ≥60 s posture parfaite
2 = 30–59 s
1 = 10–29 s
0 = <10 s

Anti-inclinaison / rotation

- Side plank (genoux ou pieds)

3 = ≥45 s par côté
2 = 20–44 s
1 = 10–19 s
0 = <10 s

- Pallof press à l'élastique

3 = 10 reps lentes sans rotation (la rep est une élévation bras tendu depuis le nombril vers la tête)
2 = Légère rotation
1 = Instabilité marquée
0 = Impossible

- Carry unilatéral "imaginaire" = tenir une charge fictive (posture)

?

Coordination tronc

- Bird-dog dynamique (coude/genou opposés) 60rep alterné

3 = Mouvement fluide, contrôle total
2 = Coordination correcte mais lente
1 = Désorganisation / perte d'alignement
0 = Impossible

- Gainage quadrupédie + déplacement lent des mains

3 = Déplacements contrôlés, bassin stable sur 2 mètres (déplacement par incrément de 10-15cm)
2 = Instabilité légère
1 = Désorganisation
0 = Impossible

Santé épaule | niveau sup donc à voir ?

- Suspension à une barre fixe

5°) ?? Tests de prépa physique simple

capacité locomotrice	force-endurance bas du corps
pousser/tirer “simple”	grip

Grille de scoring (0 / 1 / 2 / 3)

Bas du corps

- 5x Sit-to-Stand (chronométré)

3 = <10 s
2 = 10–14 s
1 = 15–20 s
0 = >20 s / impossible

- 30s Chair Stand

3 = ≥15 reps
2 = 10–14 reps
1 = 5–9 reps
0 = <5 reps

- Maintien demi-squat contre mur (isométrie)

3 = ≥90 s
2 = 45–89 s
1 = 20–44 s
0 = <20 s

- Fente statique tenue (si genoux OK)

?

Locomotion / cardio sans matériel

- Timed Up & Go (chaise → 3 m → retour) | à hiérarchiser vers un truc plus dur

3 = <8 s
2 = 8–10 s
1 = 10–14 s
0 = >14 s

- 2-minute step test (lever genoux sur place)

3 = ≥100 montées
2 = 75–99
1 = 50–74
0 = <50

- Marche continue 6 min si espace suffisant ?

Haut du corps (safe)

- Push-ups

3 = ≥15 reps propres
2 = 8–14
1 = 3–7
0 = <3

- Tirage élastique (debout ou assis) ?

3 = ≥15 reps propres
2 = 8–14
1 = <8
0 = Impossible

- Développé épaules élastique (si indolore)

3 = ≥15 reps propres
2 = 8–14
1 = <8
0 = Impossible

Préhension / global

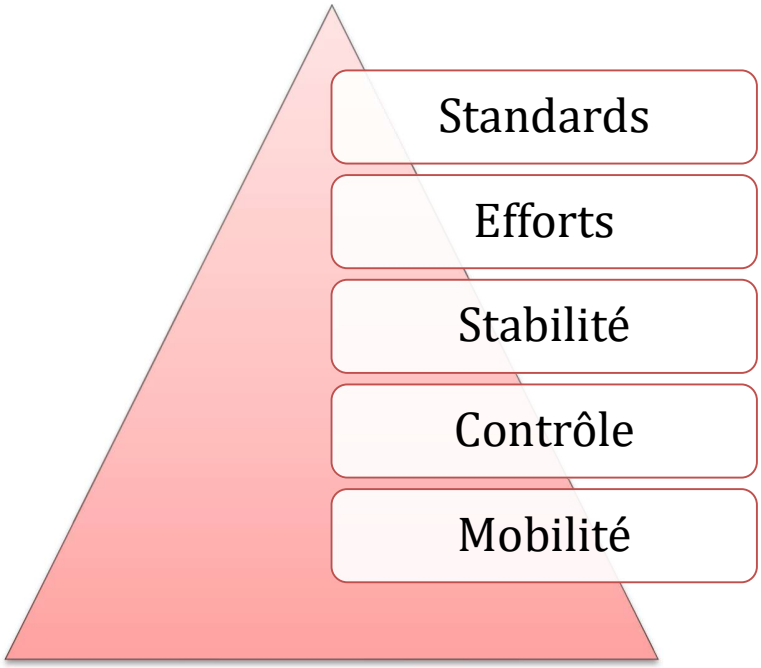
- Farmer hold avec pack d'eau de 6-9kg (F-H)

3 = ≥120 s posture parfaite
2 = 60–119 s
1 = 30–59 s
0 = <30 s

Condition d'éligibilité au STANDARD 2026

Pour une population 50–60 ans issue d'un auto-bilan fonctionnel, la cible recommandée est :
50 à 75 % des standards "santé base", selon l'historique sportif et le profil.

Mobilité • Mobilité passive ≥ **70 % du score max** • Mobilité active ≥ **70 % du score max** • **Aucun test à 0** sur les hanches, chevilles ou épaules	**Proprioception** • Score global ≥ **70 %** • Capacité à tenir **≥20 s en unipodal yeux ouverts** • Demi-tour 180° **sans instabilité majeure**
Gainage • Bird-dog ≥ **2/3** • Planche ≥ **30 s** • Side plank ≥ **30 s par côté**	**Prépa physique simple** Au moins **3 critères validés sur 4** : • 5× Sit-to-Stand ≤ **14 s** • TUG ≤ **10 s** • Chair stand ≥ **10 reps** • Push-ups ≥ **8 reps**



Podsiadlo, D., & Richardson, S. (1991). The timed “Up & Go”: A test of basic functional mobility for frail elderly persons. Journal of the American Geriatrics Society, 39(2), 142–148.

Barry, E., Galvin, R., Keogh, C., Horgan, F., & Fahey, T. (2014). Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics, 14, 14.

Shumway-Cook, A., Brauer, S., & Woollacott, M. (2000). Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Physical Therapy, 80(9), 896–903.

Jones, C. J., Rikli, R. E., & Beam, W. C. (1999). A 30-s chair-stand test as a measure of lower body strength in community-residing older adults. Research Quarterly for Exercise and Sport, 70(2), 113–119.

Bohannon, R. W. (2006). Reference values for the five-repetition sit-to-stand test: A descriptive meta-analysis of data from elders. Perceptual and Motor Skills, 103(1), 215–222.

Guralnik, J. M., Ferrucci, L., Simonsick, E. M., Salive, M. E., & Wallace, R. B. (1995). Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability. New England Journal of Medicine, 332(9), 556–561.

Springer, B. A., Marin, R., Cyhan, T., Roberts, H., & Gill, N. W. (2007). Normative values for the unipedal stance test with eyes open and closed. Journal of Geriatric Physical Therapy, 30(1), 8–15.

Araujo, C. G. S., de Souza e Silva, C. G., Laukkanen, J. A., Myers, J., & França, J. F. (2022). Successful 10-second one-legged stance performance predicts survival in middle-aged and older individuals. British Journal of Sports Medicine, 56(17), 975–980.

Plisky, P. J., Rauh, M. J., Kaminski, T. W., & Underwood, F. B. (2006). Star excursion balance test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 36(12), 911–919.

Shaffer, S. W., Teyhen, D. S., Lorenson, C. L., Warren, R. L., Koreerat, C. M., Straseske, C. A., & Childs, J. D. (2013). Y-balance test: A reliability study involving multiple raters. Military Medicine, 178(11), 1264–1270.

Rikli, R. E., & Jones, C. J. (2013). Development and validation of criterion-referenced clinically relevant fitness standards for maintaining physical independence in later years. The Gerontologist, 53(2), 255–267.

McGill, S. M. (1999). Low back stability: From formal description to issues for performance and rehabilitation. Exercise and Sport Sciences Reviews, 29(1), 26–31.

McGill, S. M., Childs, A., & Liebenson, C. (1999). Endurance times for low back stabilization exercises: Clinical targets for testing and training from a normal database. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80(8), 941–944.

Willardson, J. M. (2007). Core stability training: Applications to sports conditioning programs. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(3), 979–985.

Nelson, M. E., Rejeski, W. J., Blair, S. N., Duncan, P. W., Judge, J. O., King, A. C., Macera, C. A., & Castaneda-Sceppa, C. (2007). Physical activity and public health in older adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation, 116(9), 1094–1105.

Bohannon, R. W., & Williams Andrews, A. (2011). Normal walking speed: A descriptive meta-analysis. Physiotherapy, 97(3), 182–189.

Cesari, M., Kritchevsky, S. B., Newman, A. B., Simonsick, E. M., Harris, T. B., Penninx, B. W., & Pahor, M. (2009). Added value of physical performance measures in predicting adverse health-related events. Journal of the American Geriatrics Society, 57(2), 251–259.

Cooper, R., Kuh, D., & Hardy, R. (2010). Objectively measured physical capability levels and mortality: Systematic review and meta-analysis. BMJ, 341, c4467.

Roberts, H. C., Denison, H. J., Martin, H. J., Patel, H. P., Syddall, H., Cooper, C., & Sayer, A. A. (2011). A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies. Age and Ageing, 40(4), 423–429.

Celis-Morales, C. A., Welsh, P., Lyall, D. M., Steell, L., Petermann, F., Anderson, J., ... Gill, J. M. R. (2018). Associations of grip strength with cardiovascular, respiratory, and cancer outcomes. BMJ, 361, k1651.

Yamauchi, J., & Mishima, C. (2019). Effects of resistance training using elastic bands on physical function in older adults. Journal of Strength and Conditioning Research, 33(4), 1071–1078.

Liu, C. J., & Latham, N. K. (2009). Progressive resistance strength training for improving physical function in older adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD002759.

Fragala, M. S., Cadore, E. L., Dorgo, S., Izquierdo, M., Kraemer, W. J., Peterson, M. D., & Ryan, E. D. (2019). Resistance training for older adults: Position statement from the National Strength and Conditioning Association. Journal of Strength and Conditioning Research, 33(8), 2019–2052.